

PAUSE CARDIO ❤️

Nouveautés de la semaine du 23 août 2026

4 nouveautés cette semaine, dont 1 susceptible de changer votre pratique.

IMAGERIE CARDIAQUE **Changement de pratique** Essai randomisé · SCOT-HEART à 10 ans

Coronary CT angiography-guided management of patients with stable chest pain: 10-year outcomes from the SCOT-HEART randomised controlled trial in Scotland

The Lancet · janvier 2025 · 405(10475):329–337

4 146 patients adressés pour douleur thoracique stable, randomisés entre prise en charge habituelle et prise en charge complétée d'un coroscanner, suivis 10 ans par registres nationaux : le bénéfice observé à 5 ans se maintient, et il passe par la prévention plutôt que par la revascularisation.

Au cabinet : le coroscanner ne sert pas seulement à éliminer une coronaropathie : en montrant l'athérome, il déclenche la prévention, et c'est par là que passe le bénéfice — les revascularisations, elles, ne changent pas. Argument solide pour privilégier l'imagerie anatomique en première intention devant une douleur thoracique stable, et surtout pour *traiter* ce qu'on y voit.

[Article original](#) · [Texte intégral \(accès libre\)](#)

IMAGERIE CARDIAQUE **À connaître** Consensus d'experts · parcours de soins

Tricuspid regurgitation: standardized stepwise work-up from referral to expert heart valve centre

European Heart Journal · août 2026 · 47(30):4055–4085

Longtemps négligée, l'insuffisance tricuspide dispose désormais de solutions chirurgicales et percutanées — encore faut-il adresser les bons patients au bon moment. Ce document propose un bilan standardisé, étape par étape, du cabinet jusqu'au centre valvulaire expert, en précisant ce qu'on attend de l'échocardiographie, du scanner et de l'IRM à chaque niveau.

Au cabinet : utile comme grille de référence pour décider quand une IT cesse d'être « fonctionnelle et surveillée » pour devenir une question de centre expert — et pour envoyer un dossier déjà complet plutôt qu'une simple ETT.

[Article original](#)

IMAGERIE CARDIAQUE **À connaître** Consensus clinique EACVI

Role of multi-modality cardiac imaging in the management of patients with hypertrophic cardiomyopathy

European Heart Journal – Cardiovascular Imaging · février 2026 · 27(3):369–399

Première refonte depuis le consensus EACVI de 2015, et la première depuis les recommandations ESC 2023 sur les cardiomyopathies : le document reprend, technique par technique, ce qu'apportent l'échocardiographie, l'IRM et le scanner au diagnostic, à l'évaluation de l'obstruction, à la stratification du risque et au suivi de la CMH.

Au cabinet : la référence à ouvrir avant de prescrire une IRM chez un patient CMH, et pour savoir ce qu'il faut demander précisément au radiologue plutôt qu'un examen « standard ».

[Article original](#)

Comparison of Photon-Counting and Energy-Integrating Computed Coronary Tomography Angiography for Coronary Artery Disease

JACC: Cardiovascular Imaging · juillet 2026 · en ligne avant impression

Les scanners à comptage de photons, qui arrivent progressivement dans les centres d'imagerie, réduisent l'artefact de « blooming » calcique : la sévérité de la sténose est revue à la baisse pour 34,2 % des vaisseaux (IC95 % 27,3–41,9), avec moins de coronarographies d'aval (OR 0,71 [0,63–0,79]) et une rentabilité supérieure de celles qui sont réalisées (OR 1,43 [1,14–1,79]). Effet le plus net quand le score calcique est < 400.

[Article original](#)

Tableau de bord complet — toutes les sorties, recherche FR/EN, fiches de lecture : hacuubo.github.io/veille-cardio

Fiches rédigées par Claude — à valider par le lecteur avant toute application clinique.